Registro de control de limpieza de superficies

IDENTIFICACIÓN, OBJETIVO Y APLICABILIDAD

Formato de registro y evidencia: Registro de control de limpieza de superficies. Su finalidad es establecer trazabilidad, responsabilidades y evidencia verificable para la atención segura y la autoevaluación del consultorio.

Aplicabilidad: VERIFICAR EN LA AUTOEVALUACIÓN POR SERVICIO Y MODALIDAD.

Ámbito de uso: atención ambulatoria e infraestructura autorizada en el REPS; adaptar el contenido a las condiciones, recursos, modalidad y cartera de servicios efectivamente declarados.

RESPONSABILIDADES DIFERENCIADAS

01. Responsable técnico: médico/a competente designado/a, sin nombre preimpreso.
02. Apoyo administrativo: custodiar la versión controlada y facilitar registros completos.
03. Prestador: disponer de evidencias reales, gestionar correcciones y verificar habilitación.
04. Usuarios: recibir información suficiente, participar en decisiones y reportar alertas.

RIESGOS PRIORITARIOS DE CONTROL

01. Infección asociada a la atención: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
02. Exposición ocupacional: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
03. Error de segregación: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
04. Falta de eficacia de desinfección: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.
05. Acceso no autorizado: identificar señales tempranas, responsables, barreras preventivas y ruta de reporte.

REFERENTES NORMATIVOS PRINCIPALES

01. Decreto 780 de 2016 (SOGCS y régimen sectorial).
02. Resolución 3100 de 2019 y modificaciones aplicables (habilitación; manual anexo).
03. Resolución 2080 de 2026 (revocó la Resolución 1732 de 2026).
04. Resolución 591 de 2024 (Manual para la Gestión Integral de Residuos Generados en Atención en Salud).
05. Decreto 780 de 2016, gestión de residuos de atención en salud.

Registro de control de limpieza de superficies

SECUENCIA DE APLICACIÓN DEL DOCUMENTO

APERTURA | Verificar que la versión esté vigente, que la actividad pertenezca al alcance autorizado y que el responsable tenga competencia documentada.

IDENTIFICACIÓN | Corroborar sede, usuario o equipo según corresponda; definir fecha, turno, servicio y código del registro.

VALORACIÓN | Identificar riesgos, barreras de seguridad, contraindicación o hallazgo que exige suspender o remitir.

EJECUCIÓN | Aplicar el procedimiento escrito, las instrucciones del fabricante si son pertinentes y los controles específicos de este documento.

CIERRE | Registrar el resultado objetivo, informar hallazgos, entregar recomendaciones y activar seguimiento en caso necesario.

MEJORA | Ante desviación, abrir acción correctiva, responsable, fecha de cierre y evaluación posterior de eficacia.

VERIFICACIONES ESPECÍFICAS PARA ESTA ACTIVIDAD

01. Clasificar riesgo biológico y puntos críticos de contaminación de la actividad.
02. Definir insumos y desinfectantes con ficha técnica, concentración y tiempo de contacto.
03. Controlar frecuencia, responsables, segregación y disposición conforme a riesgo real.
04. Registrar hallazgos, incumplimientos, correcciones y reentrenamientos.
05. Validar paciente e integridad cronológica del registro sin espacios modificables sin traza.
06. Restringir acceso según funciones y justificación clínica o legal.
07. Implementar reserva, respaldo, recuperación y respuesta ante pérdida o acceso indebido.

CRITERIOS DE SUSPENSIÓN Y ESCALAMIENTO

Detener la actividad ante ausencia de competencia o autorización, condiciones inseguras, producto o equipo no conforme, negativa del paciente o signos clínicos de gravedad. Documentar la decisión y activar referencia cuando se necesite.

INDICADORES DE CONTROL SUGERIDOS

Cumplimiento documental = registros completos / registros revisados x 100. Incidentes por actividad = incidentes notificados / actividades realizadas x 100. Ajustar metas a línea base y análisis de riesgo.

Registro de control de limpieza de superficies

CONTROL OPERATIVO PARA DILIGENCIAR

Sede / consultorio:

Responsable de ejecución (sin prellenar):

Fecha de diligenciamiento y código del caso / equipo:

Actividad verificada, hallazgo y resultado:

LISTA DE VERIFICACIÓN DOCUMENTADA

Verificación	Sí	No	NA	Observación / soporte
Clasificar riesgo biológico y punto	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Definir insumos y desinfectantes co	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Controlar frecuencia, responsables,	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Registrar hallazgos, incumplimiento	[ ]	[ ]	[ ]	_____
Validar paciente e integridad crono	[ ]	[ ]	[ ]	_____

HALLAZGOS Y GESTIÓN DE MEJORAS

Hallazgo / desviación identificada:

Acción, responsable y plazo acordado:

Evidencia de cierre / verificación de eficacia:

CONTROL DE VALIDACIÓN INSTITUCIONAL

Elaboró: _____ Revisó: _____ Aprobó: _____

Fecha: _____ Versión: _____ Próxima revisión: _____

Firma del profesional responsable: _____